

의사소통 장애아동을 둔 가족의 어려움과 지원요구에 관한 질적 연구

김정연* · 이금진* · 김은숙* · 김주혜* · 박지연**
(*이화여자대학교 특수교육학과 박사과정, **이화여자대학교 특수교육학과)

김정연 · 이금진 · 김은숙 · 김주혜 · 박지연. 의사소통 장애아동을 둔 가족의 어려움과 지원요구에 관한 질적 연구. 『언어청각장애연구』, 2005, 제10권, 제1호, 58-81. 본 연구는 의사소통 장애아동을 둔 어머니가 인식하는 의사소통 장애아동이 가족에게 미치는 어려움과 그러한 어려움을 돕기 위해 가족에게 필요한 지원을 알아보기 위해 실시되었다. 이를 위하여 의사소통 장애를 가진 아동의 어머니 16명을 대상으로 심층 면담을 실시하였다. 질적 분석 결과 다음과 같은 3개의 주요 주제가 도출되었다: 1) 아동의 의사표현의 문제는 가족간의 상호작용을 어렵게 하고, 양육의 문제와 경제적인 어려움을 가져오며, 가족의 사회활동을 제한하는 등 가족생활 전반에 영향을 미친다. 2) 의사소통 장애아동의 가족은 이러한 어려움에 대하여 가족 내적으로는 가족 협력과 가족 내의 상호작용 전략을 사용하고, 가족 외적으로는 부모교육과 자조그룹 결성, 전문가의 도움을 통해 대처한다. 3) 의사소통 장애아동의 가족을 위해서는 가족간의 상호작용을 증진시키고 의사소통 능력을 향상시킬 수 있는 치료와 교육적 지원이 필요하며, 삶의 질을 높이기 위한 사회적 지원이 요구된다. 이러한 결과는 의사소통 장애아동을 위한 지원이 가족 중심의 통합적인 지원을 통해 이루어져야 함을 시사한다.

핵심어: 의사소통 장애아동, 가족지원, 장애아동 가족, 의사소통 장애, 질적 연구

I. 서 론

장애아동의 출생과 양육부담은 한 가정으로 하여금 특수하고도 지속적인 어려움을 경험하게 한다. 장애아동 가족의 경우 일상생활에서 추가 양육부담, 치료, 교육 등으로 인한 심리사회적 부담감을 느끼게 되고, 특히 아동의 어머니들은 장애아동의 욕구와 다른 자녀의 욕구를 동시에 충족시켜야 하는 갈등으로 인한 무력감을 경험하거나, 자신의 꿈과 기대를 빼앗긴 채 자신의 처지를 부정하기도 하면서 여러 단계의 심리적 변화를 겪게 되기도 한다. 또한 어머니들은 장애아동의 미래에 대해 불안을 느끼며 아동이 성장하면서 보이는 여러 문제에 직면하면서 더욱 많은 어려움을 경험하게 된다. 특히 의사소통 장애아동의 경우 학교 교육만으로 그들의 능력을 최대한으로 증진시키기가 매우 어렵기 때문에 의사소통 장애아동을 가진 부모는 일반아동의 부모보다 역할수행에 있어서도 많은 심리적 부담을 가질 뿐만 아니라 사회적·경제적 부담과 함께 여러 가지 복합적인 문제들을 해결해야 하는 어려운 상황에 놓이게 된다. 구어를 이용하여 효과적인 의사소통을 할 수 없는 중도장애아동의 경우는 의사표현의 문

제 외에 자해행동이나 공격행동과 같이 사회적으로 부적절한 행동으로 의사소통 요구를 표현하기도 하므로(Carr & Durand, 1985; Hunt, Alwell & Goetz, 1988), 어머니들에게는 의사소통 문제를 최소화하며 아동의 적절한 행동을 증가시킬 수 있도록 하는 역할이 강조된다(Warren & Kaiser, 1986).

그러나 현재 특수교육 관련기관에서 실시하고 있는 부모교육은 부모의 의견과 요구를 수용하기 보다는 형식적인 입장에서 접근하는 경우가 많고, 내용 또한 부모의 독특한 요구에 적합하지 않거나 그들이 가진 어려움이나 스트레스 요인을 반영하지 못한 채 운영되고 있다(이미선 · 김정진, 2000). 또한 현재까지 의사소통 장애아동에 대하여 많은 연구가 발표되었지만, 대부분의 연구가 의사소통 장애아동을 대상으로 한 것이며, 부모를 대상으로 접근한 연구는 매우 적은 편이다. 연구에서 나타난 중재의 형태도 직접 중재, 혹은 직접 중재에 부모훈련과 같은 간접 중재의 형태를 취한 연구들이 대부분이며 이러한 연구에서 어머니는 단순히 중재과정의 관찰자 혹은 부분적인 참여자로 간주되었다.

본 연구에서는 의사소통 장애가 아동 자신과 가족에게 미치는 영향은 무엇이며 어머니를 포함한 가족구성원들의 대처방안과 의사소통 장애아동을 양육하는 데 필요한 지원방안이 무엇인지 알아보고자 한다. 본 연구목적을 달성하기 위한 연구문제를 구체적으로 제시하면 다음과 같다:

1. 아동이 가진 의사소통 장애가 아동 자신 및 가족에 미치는 영향은 무엇인가?
2. 아동이 가진 의사소통 문제에 대해 어머니를 포함한 가족구성원들은 어떻게 대처하는가?
3. 의사소통 장애아동을 양육하는 데 가장 필요한 지원은 무엇인가?

II. 이론적 배경

1. 아동의 의사소통 문제가 가족에 미치는 영향

장애아동의 부모들은 장애자녀의 요구와 다른 자녀의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 책임을 맡고 있기 때문에 갈등을 겪으며, 장애에 대한 사회의 부정적인 태도로 인해 사회적 고립을 경험하는 것으로 보고 되고 있다. 장애아동을 양육하는 어머니는 일반 부모들에 비해 훨씬 더 큰 스트레스를 경험하게 되고(이소현, 2000), 자녀의 양육과 관련된 신체적, 정신적인 부담과 과중한 일과로 인해 스트레스를 받게 된다. 또한 부모들은 장애자녀의 특수한 문제에 어떻게 대처해야 하는지에 관한 지식 및 기술 부족, 일반학교에서의 교육 및 통합 환경에서 발생하는 부적응행동, 장애아동과 일반아동간의 적절하지 못한 상호작용으로 인한 갈등, 장애에 대한 걱정 등으로 스트레스를 받는다. 김혜란(1997)은 장애아동 가족이 겪는 어려움을, 양육 과정에서 느낄 수 있는 부모의 무력감과 부적절감 등의 정서적인 어려움, 가족 구성원간의 갈등, 의료비, 보육비, 교육비 등의 경제적인 어려움, 장애에 대한 사회적 편견과 낙인으로 인한 사회적 고립, 장애관련 서비스 부족으로 인한 어려움으로 설명하였다.

장애아동의 어머니의 스트레스에 대한 연구를 보면 장애아동의 부모들은 일반아동의 부모들에

비해 스트레스 수준이 높으며(김동연, 1996), 이러한 스트레스 중 하나는 아동을 양육하고 교육하는 과정에서 발생하는 병원치료나 치료교육비 혹은 재활기기 구입 등으로 인한 경제적 부담감인 것으로 나타났다. 현재, 각종 치료 및 재활훈련에 들어가는 비용은 국가 차원의 지원이 거의 없으므로 이러한 경제적 부담은 고스란히 장애아동의 가정에서 떠안고 있는 실정이다. 또한, 아동의 양육에 부과되는 다량의 육체적·정신적 과업들이 어머니들에게 한꺼번에 부과되므로 장애아동의 어머니들은 체력의 한계와 혼자에게 지워진 부담으로 인한 정신적인 피로로 어려움을 겪게 된다. 실제로 장애아동을 가진 많은 수의 가정들이 장애아동의 양육에 따른 많은 시간의 소요 및 정신적·신체적 피로, 가족간의 여행이나 외출 등의 활동 제한, 여가시간의 부족, 지나친 양육부담과 정서적 문제로 인한 부부사이의 갈등 등으로 인하여 위기에 처해 있다. 장애아동 가정의 일상생활에서 부모들은 휴식이 필요함에도 불구하고 장애아동에게 주의를 기울여야 하는 것으로 인해 어려움을 가지고 있으며 생활 전반에 걸쳐 문제행동으로 인해 도전을 받고 있는 것으로 나타났다(Turnbull & Ruef, 1997). 또한 장애아동의 부모가 겪는 어려움은 자녀가 자립할 연령임에도 불구하고 여전히 자녀를 돌보아야 하는 문제, 가족들이 친구를 초대하는 데 따르는 문제, 신체장애로 인한 이동문제 등 생활 전반의 문제와 더불어, 육체적 부담, 경제적 문제, 전문가와의 의사소통, 가족 문제 등 다양한 어려움에 직면하고 있다(Gammon & Rose, 1991). 부모들이 경험하는 스트레스는 가족의 안녕과 결속력에 영향을 줄 수 있으며, 장애아동의 부모들은 스트레스와 관련된 병과 만성적 불안과 같은 그러한 심리학적 문제를 가질 위험이 더 클 수 있다(O'Shea et al., 2001). 이는 장애자녀를 둔 가족의 대처능력에 있어서 어머니의 심리적인 안정과 행복감이 중요하며, 가족 지원 서비스는 가족 구성원 전체의 육체적, 정신적인 건강을 위한 지원이 필요하다는 사실을 강조하고 있다.

의사소통의 중요성은 생의 주기(lifespan)에 따라 변화하는데 영아(infants)기에는 원하는 것과 필요한 것을 표현하지 못하여 기본적인 욕구를 해결하지 못하게 되며, 유아기와 학령전기(toddlers & preschoolers)에는 의사소통을 하지 못함으로 인해 가족과의 친밀감을 형성하지 못하게 된다(Light, 1997). 의사소통 장애아동은 수용과 거부를 나타내는 신호가 미세하여 상대방이 인식하기 어렵고 부적절한 문제 행동의 형태로 나타내는 경우가 많다(Beukelman & Mirenda, 1998). 학령기 아동들의 경우에는 원하는 것과 필요한 것을 요구하는 능력이 부족해짐에 따라 점차 의사소통적인 요구가 감소하고 적절한 의사소통방법을 사용하지 못하여 또래관계 형성에 영향을 미치게 된다. 이는 사회적인 친밀감이나 다른 사람과의 긍정적인 관계를 형성하지 못하는 어려움을 나타내게 된다(김정연·박은혜, 2003). 이로 인해 부모는 장애로 인한 부담이 가중되며 어려운 상황이 반복되고 이런 상황을 스스로 해결할 수 없다는 무력감과 좌절감에 빠지기 쉽다.

2. 의사소통 장애아동의 어머니에 대한 지원서비스 및 대책

가. 의사소통과 관련하여 가족의 능력을 강화할 수 있는 부모교육 프로그램의 제공

최근의 특수교육은 아동 중심에서 가족 중심으로 변화하였고 이러한 가족 중심의 특수교육은 가

족의 참여를 전제로 하며 교육의 목적을 달성하기 위해서는 가정과 학교간의 협력을 이룰 수 있는 부모의 참여가 중요시되고 있다. 학교교육과 관련된 부모교육 프로그램은 아동의 특정한 기술 획득률을 거의 두 배로 증가시킬 수 있고(Gargiulo & Graves, 1991), 부모의 참여는 자녀교육의 참여에 대한 만족도에 영향을 주고 부모-전문가간의 공유된 가치와 믿음을 갖게 하며 협력을 활성화시켜 긍정적인 관계를 발전시킬 수 있다(Soodak & Erwin, 2000).

현재 대부분의 학교나 기관에서 실시하는 부모교육은 아동의 장애에 대한 정보나 일반적인 장애 관련 지식을 일방적으로 전달하는 데 그치고 있어 가족의 요구나 필요를 기초로 좀 더 능동적인 역할을 할 수 있게 하는 부모교육의 형태가 요구되고 있다. 특히 의사소통에 관련된 정기적이고 체계적인 부모교육이나 훈련 프로그램을 받은 경험이 없는 부모들은 일반적인 양육방법의 적용만으로는 해결될 수 없는 한계점에 자주 부딪히게 된다(Yoder & Davies, 1990). Broderick(2001)의 연구에서는 7세 자폐 소년의 반향언어와 다른 사람들이 이해하지 못하는 말에 대해 어머니가 일일이 기록하고 그것을 바탕으로 연습을 시켜서 상호작용을 시도한 결과 명료한 언어 산출로 이끌 수 있다는 성공적인 사례를 보여주고 있어, 어머니의 태도나 행동 등 민감한 반응이 아동에게 중요한 영향을 준다는 사실을 알 수 있다. 어머니의 상호작용 스타일은 아동의 언어 및 의사소통 발달에 중대한 영향을 미치므로(Mahoney & Powell, 1988), 아동의 의사소통 능력을 신장시키기 위해서는 아동에 대한 직접적인 중재도 중요하지만 대화상대자로서의 어머니 역할이 중요하므로 어머니의 참여가 중요하다(Light, Collier & Parnes, 1985).

부모교육의 내용면에서도 가족의 능력을 강화할 수 있는 내용으로 제공되어야 한다. 자폐유아를 가진 부모의 부모교육에 대한 요구를 조사한 연구(김영미, 1997)에 의하면 부모교육의 내용에 대해 부모들과 전문가들 간에 요구의 차이가 있는 것으로 나타났다고 보고하고 있다. 예컨대 부모들은 아동의 언어발달, 아동의 심리, 행동수정방법, 교육의 일반화, 양육사례, 개별상담 등의 영역에 대한 요구가 높은 반면, 전문가들은 아동의 사회성, 아동의 심리, 가족의 역할, 문제행동 수정방법, 부모회 결성, 부부간의 문제해결 등에 더 높은 요구를 보였다. 이를 통해 가족의 필요와 요구에 따라 구체적인 정보와 지원이 필요하다는 것을 알 수 있다. 즉, 가족이 겪는 어려움에 대해 궁극적으로 평가, 대처, 해결하는 능력을 가지게 하는 것이 가장 중요하며(Gammon & Rose, 1991), 사회적, 교육적 지원 및 자원을 제공하여 아동의 의사소통 능력을 신장시킴과 동시에 어머니가 적절한 대처능력을 습득하도록 도와주는 내용으로 구성되어야 한다. Bruno & Dribbon(1998)의 연구에서는 의사소통 장애아동을 대상으로 한 부모교육 프로그램의 성과를 실험하였다. 부모교육 프로그램을 실시한 결과 부모들은 아동과의 의사소통 상호작용이 향상되어 교육과 양육에 대한 자신감이 확대되었으며, 장애를 가진 다른 가족들과의 지속적인 관계를 통해 의사소통 관련 지원에 대한 많은 정보를 접할 수 있었다.

나. 지역사회 중심의 사회적 지원망 확보

의사소통 장애아동의 부모를 강화하기 위해서는 양육의 어려움을 극복할 수 있도록 장애를 긍정적으로 보고 문제를 정확히 인식하며, 이를 해결하는 기술을 습득하기 위해 도움을 구할 수 있는 사회

적 지원망이 확보되어야 한다(이소현, 2000). 사회적 지원망은 장애아동 가족과 가까운 친척이나 친구 등의 비공식적 관계에서의 지원과 직장이나 모임, 종교단체 등 공식적 관계에서의 지원, 복지관이나 병원, 특수학교 등의 프로그램이나 서비스와 관련된 지원, 장애수당이나 교육비 지원 등 장애아동 가족을 둘러싼 모든 지원과 자원을 확보하는 것을 의미한다(오혜경·전혜연, 2004). 장애아동의 가족은 장애로 인한 어려움 때문에 사회적으로 고립되기 쉬우므로 가족의 지지체계를 최대한으로 활용하도록 돕는 것이 중요하다(김혜란, 1997). 가족의 지원체계가 제대로 기능할 때 가족의 부담은 감소될 수 있으므로 장애아동 부모들이 사회적 지원망을 활용할 수 있도록 주변의 인적 자원들과 긍정적인 관계를 형성할 수 있는 기회 제공 및 방법 제시 등 다양한 통로의 지원을 제공하는 것이 필요하다.

다. 자원과 지원의 확보

의사소통 장애아동의 교육적 요구는 일반적으로 학교에서 제공되는 중재 이상의 것을 필요로 한다. 장애와 관련된 이러한 요구는 교육, 복지, 보건 및 의료 분야 등 여러 분야와 관련되어 있다. 현재 우리나라에서는 장애아동의 지원은 학교, 장애인복지관, 보육시설 등 각 기관별로 이루어지고 있는 실정이며 체계적인 지원이 부족한 실정이다. 장애아동 양육지원에 대한 한 조사에 의하면 장애아동을 양육하면서 느끼는 어려운 문제에 대해서 조부모(28.4 %), 친척(26.7 %), 동료나 친구(6.0 %), 종교기관(1.7 %)의 도움을 받고 있으며, 도움을 받을 곳이 전혀 없다고 응답한 비율이 26.7 %로 사회적 자원과 지원의 필요성이 부족함을 알 수 있다. 공공기관이나 사적 기관의 지원요구 사항에 대해서는 장애아동의 학습지도, 교육비 감면, 경제적 도움, 의료적 지원의 순으로 응답하여 장애를 가진 가족은 다양한 지원과 서비스를 요구하는 것으로 나타났다(도봉서원종합복지관, 2003).

Matas et al.(1985)은 의사소통 교육을 시행하지 못하는 많은 이유를 의사소통관련 지원의 자금 부족, 의사소통 방법을 지도하기 위한 진단과 프로그램을 제공할 전문가의 부족, 의사소통 장애아에 대한 낮은 사회적 인지도와 옹호의 세 가지로 설명하면서 전문가 교육의 필요성을 강조하였다. 미국의 경우, 장애인 교육법(602조 2항)에 의사소통 장애를 가진 이들의 제한된 능력을 보완해 줄 수 있는 방안으로 제시되고 있는 보조공학은 특수교육 관련 서비스로 규정함으로써 보조공학 도구에 대한 법적 지원을 보장하고 있다(Bowe, 2000). 이에 비해 우리나라에서는 재활기구의 구입을 위한 지원이나 의료보험 범위의 한계 등 국가 차원의 제도 및 정책이 미흡하다. 그러므로 의사소통 보조공학과 관련된 재정적 지원과 체계적인 교사 및 전문가 연수, 학교단위의 지원 프로그램을 개발하기 위한 교육정책의 필요성이 절실하다.

III. 연구 방법

본 연구는 특수교육기관에 재학 중인 의사소통 장애아동의 어머니를 대상으로 심층면담을 통하

여 어머니가 표현한 그대로의 기술적인 자료를 수집하였고, 아동의 가정환경, 교육여건 등 기본적인 환경 요소와 그 밖의 단서들을 조사하였다. 연구대상자 표집을 위해 전형적인 사례선택 전략(typical-cases selection strategy)을 사용하였다(김윤옥, 2001). 본 연구는 2004년 9월부터 2005년 1월까지 이루어졌으며, 구체적인 연구대상과 절차는 다음과 같다.

1. 연구 참여자

본 연구에서 의사소통 장애아동이란 특수교육진흥법에서 제시한 특수교육대상자 선정 기준의 ‘언어장애를 지닌 특수교육대상자’ 중 조음장애, 유창성 장애, 발성장애와 같은 말장애를 제외한 구어의 결여(no verbal language)로 인한 언어장애아동을 말한다. 본 연구에서는 언어 결함 외에 청각장애, 정신지체, 지체장애, 자폐 등 기타 장애를 동시에 보이는 아동들도 의사소통 장애아동에 포함하였다.

본 연구는 의사소통 장애로 인해 특수교육기관을 정기적으로 다니거나, 일반 유아원이나 유치원, 또는 장애아동을 위한 조기교육기관에 재학 중인 4 - 10세 아동의 어머니 16명을 대상으로 하였다. 연구에 참여한 어머니들은 33 - 44세로 평균 39세였으며 서울을 중심으로 한 수도권에 거주하고 있었고 경제적인 수준은 중산층 이상이었다. 연구 참여자에 대한 자세한 정보는 <표 - 1>과 같다.

<표 - 1> 연구 참여자

연구 참여자		아동				교육기관	
기호	연령	이름(가명)	성	연령	장애 명	기호	기관(소재지)
A	40	이수연	여	10	지체부자유	가	특수학교(서울특별시)
B	39	이종민	남	9	지체부자유		
C	38	임진아	여	9	지체부자유		
D	40	김세민	남	10	지체부자유		
E	38	박수인	여	8	정서장애	나	특수학교(경기도)
F	43	진대석	남	8	정서장애		
G	42	장하문	남	7	정신지체		
H	44	박석준	남	7	정신지체		
I	44	이승민	남	6	정신지체	다	발달장애 아동센터 (서울특별시)
J	36	정세희	남	6	정서장애		
K	35	박성진	남	6	정신지체		
L	34	최수지	남	4	정신지체		
M	33	홍경민	남	4	정신지체	라	초등학교(서울특별시)
N	38	하문석	여	10	정서장애		
O	43	홍현민	남	10	정신지체		
P	39	이경진	여	10	정신지체		

2. 연구절차

연구는 2004년 9월부터 2005년 1월까지 이루어졌다. 연구주제에 대한 선행연구를 분석하였고 서울, 경기 지역의 4개 기관에서 연구 주제에 적절한 대상자 16명을 선정하였다. 16명의 대상자로부터 동의를 받기 위한 접촉을 시도하는 동시에 이들과의 개별면담을 위한 질문지를 구성하였다. 면담 질문지는 Patton(1990)이 제시한 질문 유형의 6가지 영역, 즉, 1) 경험 및 행동에 대한 질문, 2) 의견 및 가치에 대한 질문, 3) 정서에 대한 질문, 4) 지식에 대한 질문, 5) 지각을 추출하기 위한 질문, 6) 배경 및 인구학적인 질문을 고려하여 <표 - 2>와 같은 내용으로 작성하였다. 작성된 질문지 내용의 적절성을 확인하기 위하여 2명의 의사소통 장애아동의 어머니에게 예비면담을 실시한 후 질문 내용을 일부 보완하고 면담 진행방식에 대해 연구자들 간의 협의과정을 가졌다.

<표 - 2> 면담 내용

가정의 분위기(장애수용도)	가족의 협력 정도 / 장애 수용정도 / 양육 시 어려움의 대처 방안
장애아동의 의사소통 면의 특성	장애아동의 의사소통 스타일과 수준 / 어머니와의 의사소통 방법 / 의사소통 측면의 강점, 약점 / 의사소통 촉진을 위한 방식
의사소통 장애로 인해 겪는 어려움과 대처방안	양육 시 어려운 문제, 심각정도 / 시설 이용 시 어려운 점 / 아동 관련 지출 / 월 교육비 / 가족 간의 어려움 / 어려움에 대한 어머니와 가족의 대처방안
프로그램, 기관의 이용 경험	현재까지 이용한 기관, 프로그램 / 가장 도움이 큰 기관
지원 요구사항	사적 지원 / 공적 지원 / 지원 필요 영역 / 전문가 / 필요한 전문 인력 등
필요한 프로그램, 정책	필요 프로그램, 시설 / 가족지원 프로그램 / 국가 차원의 정책 및 제도
그밖의 사항	개인의 희망사항

면담은 약속된 날짜에 면담에 동의한 어머니들을 대상으로 개별 면담의 형식으로 진행하였고, 어머니들이 편안하게 느끼는 학교 교실 및 집에서 이루어졌다. 어머니들에게는 사전에 면담에서 이루어질 질문들에 대해 전화나 안내문을 통해 제공하였고, 면접 전에는 분위기가 경직되지 않도록 하기 위해 아동 양육과정에서의 가장 즐거웠던 기억과 아동의 특성 등에 대해 물어보는 시간을 가졌다. 연구자들은 가능한 한 편하고 그들 관점에서 자유롭게 표현할 수 있도록 하였고 보충 질문을 통하여 충분한 정보를 얻을 수 있는 반 구조화된 면담 형식을 취하였으며 면담 시간은 평균 60분이 소요되었다. 모든 면담내용은 면담대상의 동의하에 녹음되었다. 면담을 실시한 연구자들은(1 - 4저자) 의사소통 장애아동에 대한 깊은 관심과 학문적 애정을 가지고 있으며 특수교육기관에서 장애아동을 평균 10년 이상 지도한 경험이 있는 전문가들이었다.

녹음된 면담내용은 면담을 마친 날로부터 일주일 이내에 전사하였고, 완성된 전사본을 분석한

후 추후 확인면담과정을 거쳐 결과를 정리하였다. 녹음자료는 면담하는 동안의 기록, 면접 후의 기록과 함께 완전 전사되었고 면담자료는 A4 용지 약 160장으로 전사되었다. 아동의 출생 전, 출생 시, 출생 후의 특이사항과 섭식 및 수면, 신체 발달, 언어 발달, 신변 처리에 대한 생육사와 질병 경력, 교육 경력, 현재 장애의 상황과 양육 환경, 아동의 상호작용 패턴 등을 기초 상담 기록지를 이용하여 기록하였다.

3. 자료의 분석

본 연구의 자료 분석은 심층면담 내용에 대한 획득된 원자료를 기초로 하여 질적 분석의 특성에 따라 다음과 같은 절차를 기준으로 분석, 범주화 하였다. 4명의 연구자팀은 개별적으로 전사본 4개씩을 읽은 후 다함께 모여 주제(theme)를 토의하여 주제명에 코드명을 부여하고 첫 번째 코드북을 작성하였다. 연구자들은 2명씩 짝을 지어 8개의 전사본을 초기 코드북에 따라 분석하고 새로운 주제(theme)나 변화를 기록하고 이에 대한 의견일치를 본 다음 모든 연구팀과 모여 토의하여 새로운 코드북을 작성하였다. 이러한 과정을 2번 더 거쳐서 전사본 16개에 대한 코드북이 4개가 나왔고 마지막으로 전체에 대한 내용을 연구자들이 토의하여 최종 다섯 번째 코드북을 작성하였다. 4명의 연구자들은 코드를 부호화하고 코드명을 수정하면서 결과물에 대해 논의하였고 최종적으로 3개의 주제와 22개의 하위주제로 정리되었다.

4. 연구의 신뢰도

Glesne & Peshkin(1992)이 제시한 질적 연구의 포괄성을 높일 수 있는 대안과 Goetz & LeCompte(1984)가 제시한 질적 연구에서의 신뢰도 및 내적 신뢰도에 영향을 미칠 수 있는 요인들에 근거하여 신뢰도를 확보하였다. 본 연구에서는 신뢰도를 확보하기 위하여 다음과 같은 노력을 기울였다. 첫째, 연구과정에 투입된 시간 여하가 연구 결과의 신뢰성을 높일 수 있는 중요한 요인이 되나 한 번의 면담만으로는 연구 참여자와 관계를 형성하는 것이 다소 어려울 수 있어 가능한 한 면담시간을 충분히 하여 자료수집기간을 확보하고자 하였다. 또한 단순한 연구 결과보다는 삼각측정법에 의한 연구 결과들이 보다 신뢰로울 수 있다는 Glesne & Peshkin(1992)의 지적하에 면담자료 외에 기관 내에서 관리하고 있는 아동에 대한 교육계획자료를 참고하였다.

둘째, 본 연구에서는 연구의 신뢰성을 높이기 위한 방안으로 연구자의 주관성을 피할 수 있는 방안, 즉, 연구에 대한 해석과정을 공유하고, 면접내용에 대한 통합된 관점을 확인하기 위해 다수의 연구자들이 매주 1회 이상의 정기적 모임을 가졌다.

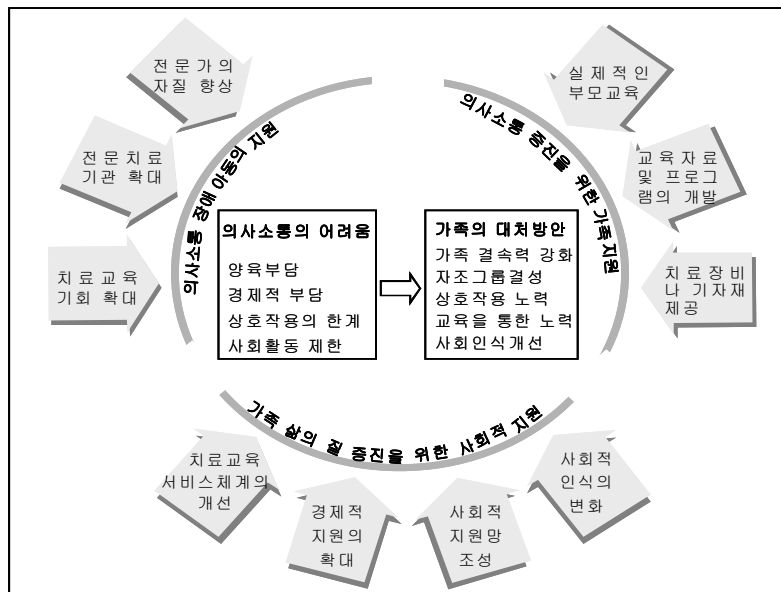
셋째, 모든 면담자료를 완전 전사하였고 코딩 과정에서 연구자들이 짝을 이루어 점검하였다.

넷째, 참여자의 점검을 통해 확인해 보는 추후 확인면담(member check)을 하여 연구자의 주관성을 피할 수 있도록 하여 신뢰성을 확보하였다. 추후 확인면담은 8명의 참여자에게 요약된 해석과 결

론을 피드백 용지와 함께 면담참여자들에게 발송하고 이메일과 전화를 이용하여 실시하였다. 추후 확인면담에서의 질문은 1) 본인의 견해가 잘 반영되었는가? 2) 중요한 요점이 빠지지 않았는가에 해당하는 것이었다. 이에 대해 8명 모두 결론에 반대하는 입장은 없었으며 내용에 대한 추가설명, 참여자 스스로에 대한 성찰 및 소감을 포함하는 내용이 다수 포함되어 있었다.

IV. 연구 결과

면담을 통해 수집된 자료는 질적 분석 절차를 거쳐 아래와 같은 3개의 주제로 범주화되고 각각의 하위 주제는 다음과 같이 정리되었다: 1) 의사소통 장애가 가족생활에 미치는 어려움, 2) 의사소통 장애로 야기되는 가족의 어려움을 해결하기 위한 노력, 3) 의사소통 장애아동을 양육하는 데 필요한 지원. <그림 - 1>은 이 3개 주제들의 유기적 관계를 도식화 한 것이다.



<그림 - 1> 주제들 간의 유기적 관계

1. 의사소통 장애가 가족생활에 미치는 어려움

의사소통 장애아동을 양육하고 있는 어머니들이 다양한 실례와 함께 제시한 의사소통의 장애가 가족생활에 미치는 어려움은 다음과 같다. 첫째, 의사소통 장애는 어머니의 양육 부담을 증가시키고,

둘째, 가족경제의 어려움을 가속시키며, 셋째, 장애아동과 가족간의 상호작용을 어렵게 하며, 넷째, 가족의 사회활동 참여를 제한한다.

가. 어머니의 자녀 양육부담 증가

본 연구에서 인터뷰한 16명의 어머니들 모두 혼자서 아동을 돌보고 가르쳐야 한다는 부담감으로 인해 힘들어하고 있었다. 특히 의사소통을 스스로 하지 못하는 자녀로 인해 한 어머니는 “제가 아이 통역사예요. ○○ 말까지 다 해주고 아빠 말도 전해주고 그러니까....(가-C, p. 3)”라고 언급하면서 어머니 외에 다른 가족구성원과의 의사소통이 어려운 상황을 설명하였다. 대부분의 어머니들이 장시간의 양육으로 힘들고 지쳐있는 것으로 나타났다. 어머니들은 자신만의 시간을 가지려 해도 어머니처럼 아동을 돌봐주고 의사소통이 이루어지는 양육자가 가정에도 외부에도 없기 때문에 마음 편하게 자신의 시간을 보낼 수 없으며 서둘러서 집으로 돌아와야 한다고 말했다. 아동 곁을 비워야 하는 시간이 생겨도 이러한 복합적인 요인들로 인해 아동의 양육과 교육을 어머니가 늘 혼자서 감당해야 하는 상황이 지속적으로 반복되면서 어머니들을 힘들게 하고 있었다.

‘난 왜 이렇게 살까?’하면 한없이 몸이 처지고 다운되죠. (가-B, p. 1)

집에 들어오면 편안한 안식처가 되었으면 싶은데 집에 들어와도 아이들이 이 모양이니까...한시도 마음 놓지 못하고 매어있어야 하지요. 아이가 예쁘다 하다가도 속이 터지죠. (다-L, p. 9)

어머니들은 장애아동 뿐 아니라 함께 양육하는 비장애형제들의 양육으로 인해 좀 더 다른 측면의 어려움을 호소하고 있는데, 면담한 16명의 어머니 모두 이러한 어려움을 표출하였다. 이는 장애아동에게 치중된 양육으로 인해 비장애형제 돌볼 시간이 절대적으로 부족하고 이로 인해 어머니 자신이 가지게 되는 미안함과 죄책감에 기인한 것이다. 어머니들은 장애를 가진 자녀로 인해 비장애형제가 겪을 어려움을 고려하여 “같은 학교에 보내고 싶지 않아요.”라고 언급하여 비장애형제가 장애를 가진 형제와 같은 학교에 재학하게 되면 장애형제로 인해 불이익을 받거나 놀림을 받을까 두려워하고 걱정하는 어머니의 심정을 표현하였다. 또한 어머니들은 비장애형제가 장애형제를 다른 사람에게 설명해야 하는 부담과 어려움, 어머니를 돕는 보조 양육자로서의 역할 등 과중한 역할들이 부과되는 것에 대해 안타까워하였다. 이러한 양육의 부담과 죄책감 등으로 인한 부부간의 불화까지 경험하게 되었다는 어머니도 있었다.

나. 가족 경제에 미치는 어려움

16명 어머니 전원이 의사소통 장애아동의 치료와 진단 등을 위해 부담해야 하는 비용으로 인한 경제적인 어려움을 지적하였다. “내가 돈 때문에 걱정하게 될 줄은 몰랐어요. (가-B, p. 3)”, “밑 빠진

독에 물 붓기로 돈은 들어가도 들어가도 끝이 없는 거예요.(다-L, p. 7)”라고 하면서 병원에서 치료를 받다가 비용을 감당하기 힘들어서 저렴한 복지관으로 서비스를 바꾸기도 하고 경제적인 어려움으로 치료를 포기하는 상황도 빈번하게 일어난다고 하였다. 장애아동들에게 필요한 치료와 서비스는 한, 두 달로 효과를 보는 것이 아니라 끝도 없이 계속되는 과정이므로 어머니들을 한층 더 힘들게 하고 지치게 하는 요인이 되고 있었다.

언어치료를 시작한 건 4살, 5살쯤이었어요. 그 때 벌써 시작했었어요. S병원에서 물리, 작업, 언어 3개 다 했었어요. 1년 안에 천만원 후딱 까먹었잖아요, 그 때 어머니가 분가할 때 어떻게든 치료시켜서 낮게 하라고 통장에 천만원을 넣어주셨는데... 맨날 뽑아 쓰다가 어느 날 찍어보니까... 짹 찍히고... 남은 게 없더라고요. (가-B, P. 3)

거기 치료실은 좋았는데 너무 비싸니까 엄마들이 중간에 포기하는 걸 많이 봤거든요. 그냥 계속 했으면 훨씬 좋아졌을 텐데 경제적인 것 때문에 많이 중간에 포기해서 안 좋은 것을 봤어요. 안 됐죠 뭐. 솔직히 엄마들이나 아빠 친구들이 그래요... 돈이다! 그래요. (라-N, p. 4)

언어치료라는 게 굉장히 시간이 오래 걸리잖아요. 금방금방 나타나는 게 아니라 이런 애들은 시간이 오래 걸리기 때문에 오랜 기간 투자를 해야 되는데 너무 비싸서 맘대로 할 수 있는 게 아니거든요. (라-N, p. 4)

다. 가족이 아동의 요구에 반응하는 범위의 한계

의사소통 장애를 가진 아동들은 인간의 기본적인 욕구인 먹는 것, 배변 욕구 등의 표현을 제대로 하지 못하고 이로 인해 생활 속에서 겪는 어려움이 많았다. 이러한 어려움은 아동들이 욕구를 표현하거나 도움 청하기 등의 방법을 통해 해결하지 못해서 겪는 어려움이라 할 수 있는데, 16명 중 7명의 어머니가 먹고 싶은 것에 대해 아동이 제대로 표현하지 못해서 겪는 어려움이 있음을 나타내었고, 6명의 어머니가 배변욕구를 표현하지 못해서 생기는 어려움이 많다고 하였다.

또 어머니와 함께하는 장소나 상황에서는 어머니가 아동의 욕구나 필요를 적절하게 해결할 수 있기 때문에 발생하는 문제는 많지 않으나, 학교나 다른 사람에게 아동을 잠시 맡겨야 하는 상황에서는 이로 인한 어려움이 자주 발생하는 것으로 나타났다.

학교에만 가면 화장실 가고 싶다는 말을 못해서 그렇게 바지에 싸는 거예요. (라-P, p. 8)

우리 ○○이는 먹기 싫건 먹고 싶건 간에... 이것저것 비벼가지고 맨날 주는 것만 먹을 수 있으니까. 선택의 여지가 없잖아요. 사람이 제일 중요한 게 먹고 자고 싸는 건데... 그냥 죽지 않으려고 먹는 것 밖에 아닌 거 같아요. 그게 불행한 거 같아요. (가-D, p. 5)

어머니들은 아동이 기본적인 욕구 표현을 하지 못해서 생기는 문제 외에도 구체적인 상황에서

도대체 왜 그러는지 알 수 없기 때문에 생기는 어려움도 언급하였다. 뇌성마비 아동의 경우에는 아동이 의사표현의 의지는 있으나 표현할 통로나 방법이 없어서 겪는 어려움이 많았다. 자폐아동의 경우에는 의사표현의 의지가 없거나 대화를 할 수 없어서 어떤 상황인지 알 수 없는 상황이 자주 발생하게 되고 여러 번의 시행착오 끝에서야 뒤늦게 알게 되므로 좀더 다른 방법으로라도 아동과 의사소통이 될 수 있는 방안을 찾기 원하였다. 면담한 어머니들 중 일부는 또래와의 관계에서도 적절한 설명을 하지 못해서 오해를 받기도 하며 종종 자신이 하지 않은 일까지 누명을 쓰기도 한다고 생각하였고, 어디가 아픈지 표현하지 못해서 효과적으로 치료를 받기도 힘들다고 하였다.

근데 그게 제일 가슴 아프더라고요. 지가 어디 아플 때, 그러니까 신발을 새것을 사서 발가락이 까졌어요. 애가 아파 소리를 못했는데 내가 그것도 모르고 왜 안 들어와 소리 지르면서 때렸거든요. 나중에 그걸 알았을 때 얼마나 미안하고, 마음 아픈지. 이 정도의 말은 해야 되지 않나. (라-N, p. 4)

아. 귀에 개미가 들어갔는데... 왜 그런지를... 애는 고래고래 우는데 설마 귀에 개미가 들어갔으리라고는 생각을 못했고... 울다 울다 나중에 어디 아프냐고 물었더니 귀가 아프대요. 혹시나 하고 이렇게 먼봉으로 막 했더니 개미가 나오는 거예요. (가-A, p. 3)

라. 가족의 사회활동 제한

의사표현의 문제로 인해 아동들은 가족들과의 대화에 참여하기가 어려워지고 가족모임이나 친구모임 등에서도 관계에 참여하거나 유지하기가 힘들어진다고 하였다. 16명의 어머니 모두는 장시간 이런 현상이 반복되면서 아동 돌보기에만 급급하는 어머니 역시 친구도 못 사귀게 되고 점차 주변과 단절되어 사회적으로 고립되었으며 이로 인해 가까운 친척이나 가족간에도 기본적인 유대를 형성하지 못하게 된다고 답변하였다.

가족모임이나 그런 게 있을 때, 오늘은 자볼까 하다가도 불안해서 당일치기로 갔다 오게 되죠. 한번 옮기 시작하면 계속 우니까. 이유도 없이. 모임이고 뭐고 중도에... 하도 많이 그런 경우가 많아서... 그리고 나서 시골에 갔다 올라오면 남편이랑 싸움이 되거든요... 그런 문제에 대해서... 그래서 너무 질려요... (나-H, p. 2)

장애를 가진 아동의 모습을 수용하지 못하는 사회 곳곳의 냉대와 차별의 모습을 온몸으로 감내해야 하는 어머니들의 어려움이 면담내용 속에 고스란히 투영되어 나타났다. 장애아동을 거부하는 일반 유치원이나 학원들 때문에 상처받은 경험과 주변 사람들의 따가운 시선을 한, 두 번씩은 경험한 어머니들이 대부분이었다. 남들처럼 대형 쇼핑몰의 놀이시설을 이용하려고 해도 장애를 가진 아동이라는 이유로 놀이방에 출입조차 할 수 없었던 어머니들의 아픈 경험이 면담 중에 표출되었다.

요즘에는 쇼핑 센타에 보면 어린이 놀이방이라고 있잖아요. 엄마들 쇼핑하라고 잠깐 봐주는 데가 있잖

아요. 거기를 들어가려고 하는데 애는 안돼요...입구에서 바로 그러는 거예요. 장애인이니까 이상한 행동을 하거나, 다른 애를 어떻게 해 할까봐 그러는 거더라고요. 그래서 제가 오기로 그 다음 주에 또 갔어요. 또, 잠깐만 놀게 할게요. 얼마예요? 그랬더니 바로 또 애는 안돼요. 기억을 못하는 거예요. 우리 아이를 그 전에 왔던 애라는 걸 기억을 못하더라고요. 그래서 제가 또 갔죠. 다섯 번을 갔거든요. 다섯 번을 다 퇴자 맞았어요. 저는 너무 슬퍼요. 거기서 싸울 수도 없어요. 사실은 애를 세워놓고 싸운다는 자체가 저만 우스울 것 같더라고요. 주위에서 다 쳐다보고 할 테니까. (나-F, p. 12)

2. 의사소통 장애로 야기되는 어려움을 해결하기 위한 노력

의사소통 장애아동을 양육하고 있는 어머니들은 자신들의 어려움을 극복하기 위해 나름대로의 해결방안을 찾기 위해 노력하고 있었는데 그 내용을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 아동의 의사소통 능력을 향상시키기 위한 노력을 하고 있었으며, 둘째, 아동과 의사소통 상호작용을 시도하기 위해 여러 가지 촉진전략을 찾아서 사용하고 있었고, 셋째, 가족간의 협력을 통해 어려움을 극복하기 위해 노력하였으며, 넷째는 자신과 비슷한 처지의 부모 모임과 같은 자조그룹을 결성하여 정보 제공 및 지지를 받고자 하였으며, 다섯째, 주변사람들에게 장애를 가진 자녀를 이해시키기 위한 노력을 하고 있었다.

가. 아동의 의사소통 능력 향상을 위한 직접적 노력

아동의 의사소통의 문제를 해결하기 위해 적극적으로 어머니가 노력을 하고 있었는데 16명 어머니 모두 아동의 언어능력 신장을 위한 언어치료를 받기 위해 먼 거리까지 데리고 다니는 등 많은 노력을 하고 있었다. 그러나 전문적인 정보를 얻는 데에는 한계가 있으며 정확한 안내를 해 주는 사람이 없다는 아쉬움을 언급하였다. 16명 어머니 모두 도움이 되는 정보를 제공받기 위해 부모교육이나 연수에 참가한 경험을 가지고 있었으며, 그중 한 어머니의 경우 2년간 지속적인 교육 프로그램에 참가하여 언어치료사 2급 자격증을 취득한 경우도 있었다.

제가 10년 동안 ○○이를 데리고 다니면서 학교 안이든 밖이든 제일 아쉬운 게 엄마들이 선생님들한테 물어보면 대답은 해주시는데... 정보가 별로 없다는 거예요. 알아서 정보를 주진 않잖아요. 책을 봐도 별로 없어요. 솔직히 말해서 책은 전문용어라 잘 모르겠어요. (가-A, p. 5)

언어치료요. 엄마 노력 밖에 없어요. 그동안 다니면서 배운 것도 많아서요. 이제 반 교사, 반 치료사 다 됐잖아요. (가-B, p. 4)

16명의 아동 모두 전문가를 찾아 치료를 받고 조언을 구하고 이를 토대로 생활 속에서 활용하고자 노력을 기울이는 것으로 나타났고 이를 통해 언어능력 신장을 위한 전략과 정보들을 제공받고 있는 것으로 나타났다. 그러나 집 근처에서 쉽게 이용할 수 있는 치료 기관이 부족하여 원하는 서비스를 받는 것이 어렵다고 호소하였고, 언어치료를 담당하는 전문가의 자질 등에 불만을 가지고 있는 어머니들

이 다수 있었다.

언어치료에 뭐가 제일 중요한지 아세요? 그게 바로 자세거든요.. 근데 어떤 언어치료 선생님들은 아이가 어떻게 앉는지... 뇌성마비의 성향을 모르니까... 다리가 들려있고 자세가 어정쩡하면 벌써 불안해서 말도 꼬여요. 발음도 소리도 안 나와요. 그런 거부터 시작해서 언어치료는 언어치료 하나만이 아니잖아요. 언어치료는 전문적으로 포괄적으로 제대로 교육을 해야 돼요. (가-B, p. 7)

나. 언어적 촉진 전략을 사용한 상호작용 시도

의사소통 장애아동을 양육하는 어머니들은 아동들의 의사소통 능력을 신장시키기 위한 나름대로의 의사소통 방법과 전략을 모두 소유하고 있었다. 그 중에는 흔히 전문적인 치료 상황이나 교육방법으로 활용되는 언어교수 전략이 다수 포함되어 있었는데 전문적인 교육을 받은 상태는 아니지만 어머니 나름대로 환경교수전략을 생활 속에서 다수 활용하고 있었다. 아동들과 의사소통 능력을 신장시키고 언어적인 자극을 충분히 제공하기 위해 생활 속에서 늘 많은 이야기와 설명을 제공하고 있는 어머니들이 많았으며 이러한 방법들은 대부분 치료교육기관이나 학교의 부모교육이나 연수를 통해 얻게 된 방법들이었다. 이러한 어머니들의 촉진 전략을 정리해 본 결과는 다음과 같다.

- 상황과 장소를 가리지 않고 아동에게 필요한 사물이나 상황을 열심히 설명해 주고 반응을 이끌어내기.
- 네/아니오로 답할 수 있도록 질문을 간결하게 하기.
- 아동이 말하고 싶어 하는 것을 정확히 알 수 있을 때 까지 범주를 좁혀 가면서 네/아니오로 선택하도록 하면서 인내를 가지고 의사소통 노력을 기울이기(예: 스무고개 식의 게임).
- 같은 내용의 말을 아동이 반복하여 따라하도록 하기.
- 아동이 적절한 의사소통 시도를 할 수 있도록 충분한 시간을 주기(예: 아동이 무언가 표현하고자 할 때 먼저 말하지 않고 표현할 때 까지 기다려주기).
- 그림카드나 낱말카드를 이용하여 대화하기.
- 아동이 표현한 것을 알아들었으면서도 좀더 정확하게 표현할 수 있도록 반응하기.
- 기타 소수 의견이기는 하였지만 말하고 싶은 것에 대한 단서가 될만한 것을 찾아오게 하는 방법을 사용하기도 하였다.

다. 가족간의 결속력을 강화하기 위한 노력

장애아동으로 인해 늘 어려움을 경험하는 어머니들이지만 가족의 협력으로 많은 부분 힘을 얻고 다시 노력을 기울일 수 있었다고 응답하였다. 16명의 어머니 중 11명이 아빠의 지원이 큰 힘이 되는 것으로 나타났다. 그러나 가족들의 지원과 협력은 처음부터 그런 경우라기보다는 어머니의 꾸준한 노력

의 결과로 볼 수 있었다.

집에서 ○○이는 필요한 게 있어도 엄마한테만 하니까 아빠도 그게 속상했나 봐요. 그래서 자기가 뭐 좀 해 줄라고 그러면 애 표정이 싫다고 그러고, 울고 그러니까, 외출을 해도 아빠랑 같이 나가면 울고 소리 지르고 난리가 나는 거예요. 근데 같이 하는 시간을 점차 늘리니까 나아지더라구요. 아이가 좋아하는 놀이도 같이 하게 하고 그러니까. 이젠 많이 통해요. (라-L, p. 2)

○○이랑 말이 안 통할 때 몸이든 뭐든 표현해봐. 하고 싶은 거 말해봐... 가져오든가...근데요 아시다시피 뭘 얼마나 표현할 수 있겠어요. 눈으로 표현하는 것도 한계가 있지... 눈에 보이는 거나 짚을 수 있지... 처음엔 “애 뭐라 그래?” 그래도 제가 중간에서 알려주지 않았어요. 그러면 오랫동안 뭐라뭐라해서 통하게 되 있어요. 저는 그냥 놔두었어요. 그래야 아빠도 형아도 다 알아들을 수 있게 되니까요... 형아도 이젠 다 적응이 되서 잘 알아들어요. 아빠도 그렇고요, 집에선 문제가 없는 거죠. (가-B, p. 6)

가족 외에 지원이 되는 친척으로 친정어머니라고 응답한 어머니가 3명, 시어머니로 응답한 어머니가 1명으로 나타났다. 이 중 한 어머니의 경우, 아동으로 인해 힘들 것을 염려해서 시설에 맡기도록 권유한 친정어머니보다는, 큰 도움을 주지 않았더라도 아이를 더 신경 써서 잘 키우라고 격려하는 시어머니를 더 협조적으로 생각한다고 응답하였다. 즉, 어머니들은 자기 자신보다는 자녀에 대해 희망과 기대를 가지고 지켜봐 주는 정서적인 지원을 훨씬 큰 지지로 받아들이고 있었다.

라. 자조그룹의 결성

장애아동의 어머니들은 학교나 치료기관에서 만난 같은 처지의 부모들을 통해 정보를 얻기도 하고 위로를 받기도 한다고 응답하였고 아동들을 서로 봐 주거나 부탁을 하는 등 도움을 주고받고 있었다. 이들은 심리적으로 힘들고 어려운 점을 서로 위로해 주고 경험담을 공유하면서 상당 부분 지지를 얻고 있는 것으로 나타났다. 특히 자녀의 장애유형과 정도가 유사한 경우에는 좀 더 구체적인 정보를 주고받을 수 있으며 어느 정도 예후도 추측할 수 있으므로 더 많은 공감대를 형성하는 것으로 나타났다. 구체적으로는 장애영역별 부모집단의 모임이나 학교나 복지관 등의 부모회 모임 등에서 도움을 얻는 경우가 많았으나 좀 더 많은 기회가 주어지길 희망하였다.

엄마들끼리는 서로 처지를 아니까 애도 봐주고 부탁도 하고, 같은 처지에 있는 엄마들끼리 나는 이런 걸 겪었는데 이렇게 했더니 좋아졌고 이런 거를 써보니 좋더라는 정보를 교환하게 되는 것 같아요. (라-N, p. 3)

선배 엄마들 만나면 말을 잘 안 해줘요. 일단 대화할 기회가 별로 없으니까. 나도 그런 거 같아요. 내 밑에 ○○이 같은 비슷한 타입의 아이를 보면 저는 딱 보면 아는데. 뭐라 딱히 가서 이야기를 해주기가 어려워요. 소통이 많아야 될 것 같아요. 통로가 된다면 저도 해 줄 말이 있거든요. (가-A, p. 6)

다른 사람의 말을 많이 듣게 했어요, 내가 말하는 거보다 같은 처지에 있는 아빠들 있잖아요... 그게 굉장히 사람의 마음을 움직이게 한 것 같아요. (다-L, p. 2)

마. 아동의 장애를 이해시키기 위한 노력

자신의 자녀들을 이해시키기 위해 대부분의 어머니들은 간단히 아동이 아프다거나 아직 치료 중이라고 하는 등 소극적으로 대응하고 있었고 2명의 어머니는 매우 적극적인 노력을 기울인 것으로 나타났다. 한 어머니의 경우 아동의 상태와 증상, 그리고 그 아동에 대한 이해를 구하는 간단한 편지를 작성하여 여러 통 가지고 다니면서 아동에 대한 질문이나 반응이 올 때마다 편지를 나누어 주었다고 이야기하였고 한 어머니의 경우 아동의 장애와 관련해서 부적절한 반응을 보이는 상황에서 적극적으로 설명하고 설득하는 방법을 사용하는 것으로 나타났다.

야, 재 좀 봐, 재 좀 봐... 이런 애들도 있잖아요... 물려가면서... 저는 부르죠, 또... 저는 불러요... 불러서 설명을 해주고 다음부터는 그러지 말라고... 그게 더 효과가 있어요... 사실은... 소리 지르고 그러면 애들이 도망가죠... 무서운 표정으로 낮게 얘기를 해요 저는... 이러 이러해서 이런 것이니까 다음에 보면 절대 그러지 말아라. 그럼 못난 사람이라고 얘기를 하면 보통 4, 5학년이면 애들이 생각이 있어요... 얘기를 하면 부끄러워하더라고요. (나-F, p. 12)

3. 의사소통 장애를 가진 아동을 양육하는 데 필요한 지원

의사소통 장애아동을 양육하고 있는 어머니들을 위해 어떤 지원이 어떻게 제공되어야 할지에 대한 연구 참여자들의 응답을 분석해 본 결과 다음과 같은 세 가지의 하위주제로 요약되었다. 첫째, 아동의 의사소통 능력을 증진시키기 위한 전문가의 전문성 신장과 공교육 기관에서의 치료 기회의 확대, 둘째, 아동-가족간 의사소통 상호작용을 증진시키기 위한 부모교육 기회의 증가와 교육기자재 확충과 보급, 셋째, 의사소통 장애아동 가족의 삶의 질을 증진시킬 수 있도록 사회 전반에서 나타나는 장애에 대한 차별과 냉대를 제거하고 장애아동을 이해하고 더불어 살아가고자 노력하는 사회 분위기로의 변화이며, 면담 내용 중에 표출된 어머니들의 지원 요구사항을 분석해 보면 다음과 같다.

가. 아동의 의사소통 능력 증진을 위한 지원

아동에게 필요한 전문적인 치료나 교육을 제공하는 전문가의 자질 향상이 필요하다는 의견이 어머니들로부터 제기되었다. 또한 복지관이나 사설 치료실의 경우 경력이 충분치 않은 교사들이 치료를 담당함으로 인한 경력 및 전문성의 결여를 문제로 제기하였다. 언어를 일상생활에서 적용할 수 있도록 지도해야 하는데 “방안에서 책상 앞에서 일대일로 아무리 가르쳐도 일상생활에서 적용이 안 되므로 실제로 적용이 가능한 방법으로 전문적인 치료를 제공받고 싶다”는 의견이 제시되기도 하였다. 또한 치료사 뿐 아니라 특수교사도 의사소통 관련 지식이 부족하거나 결여된 교사들이 많아 전문성 있는 교육

을 제공받기 어렵다는 사실을 지적하였다.

아동이 학령기에 해당하는 어머니들은 모두 학교에서 자녀들의 장애 특성을 고려한 전문적인 치료를 제공받고 싶어하였고 현재 받고 있는 치료교육 서비스의 양적인 확대와 질적인 향상을 희망하였다. 즉, 공립이든 사설기관이든 기관의 성격이 중요하다기 보다 치료를 제대로 하고 있는 곳이라면 어디든 찾아다니고 있는 어머니들이 많았지만 치료를 제공받을 수 있는 전문 치료기관의 부족으로 장애 아동이 필요한 시기에 곧장 치료를 제공받을 수 있는 경우는 거의 없다는 의견이 공통적으로 제기되었다. 그러므로 치료를 받기 위해서 늘 대기 시간이 1년에서 길게는 2년까지 기다려야 하는 상황이 생기고 그 이후 정작 대기를 끝내고 치료를 받으려고 하면 아동의 연령이 치료기관에서 정한 기준을 초과했다는 이유로 기회조차 제공받지 못하는 경우가 가장 안타깝고 속상한 일이라는 이야기를 들려 준 어머니가 다수 있었다. 또한 초등학교 시기보다 중학교 이후에 치료나 장애관련 서비스를 제공받을 수 있는 기회가 전무한 실정이므로 중학교 시기에도 받을 수 있는 지원이 있기를 희망하였다.

정말 언어치료 중요해요. 근데 돈 있으면 언어치료 하는 거고 돈 없으면 못 받는다고 해요. 말 할 수 있는 아이들만 받는 게 아닌데... 복지관에서는 4년 기다려야 해요. 언어치료 받으려면 최하 4년 기다려야 하는데 기껏 기다리다보면 나이가 10살이 넘어 나이제한에 걸려서 또 잘리고 못 받게 되죠. 제한 연령이 있어서... 10세예요... 선생님들은 10살까지 받아야 한다지만 그게 순서가 오지 않는다는 거지요. 순서가 안와요. (가-C, p. 7)

나. 아동-가족간 의사소통 상호작용 증진을 위한 지원

기관별로 제공되는 부모교육의 기회는 증가하고 있으나 내용면에서 실제 부모들이 원하는 방향으로 제공되는 프로그램은 턱없이 부족한 실정으로 나타났다. 즉, 장애이해나 이론적인 교육내용보다 실제적으로 활용할 수 있는 교육을 받고 싶어 하였으나 이러한 측면을 강조해서 교육이 이루어지는 기관이 거의 없다는 것이다. 외형상으로 부모교육의 기회가 증가하고 양적으로 기관도 증가하였으나 내용면에서 어머니들이 교육을 받고 도움을 받을 수 있는 것은 실상 과거와 큰 차이가 없다는 것이 가장 큰 문제로 나타났다. 또한 어머니들은 의사소통 관련 소프트웨어나 교육자료를 쉽게 구입하여 활용할 수가 없기 때문에 다양한 교육자료 및 프로그램이 개발되고 가정에서도 쉽게 활용할 수 있기를 원하였다. 어머니들 중 일부는 아동의 의사소통 문제를 도와줄 수 있는 보완대체 의사소통 도구를 비용 부담 없이 교육기관이나 복지관 등에서 대여할 수 있기를 희망하였고, 기자재의 종류와 구입 방법에 대한 정보를 필요로 하였다.

언어치료 도구는 굉장히 없기도 없을뿐더러... 이런 새로운 기계가 나오면 정기적으로 학회나 세미나가 있어서... 부모님들 프로그램 통해서 이런 거(보완·대체 의사소통도구) 소개하는 거나 사용방법 같은 거... 구입하는 방법이나 그런 정보가 있었으면 해요. (라-N, p. 10)

다. 의사소통 장애아동 가족의 삶의 질 증진을 위한 지원

의사소통 장애아동의 어머니들은 가족의 삶의 질을 증진하기 위해서는 다양한 지원과 서비스를 통합하고 조정할 수 있는 서비스 체계가 이루어지기를 희망하였고 또한 장애로 인한 교육과 치료에 따른 경제적 지원과 장애아동 가족을 지원해 줄 수 있는 사회적 지원망 구축과 함께 사회적 인식이 변화되기를 희망하였다.

첫째, 어머니들은 아들에게 필요한 교육적, 치료적 지원을 전문가가 직접 찾아와서 제공해 주는 시스템이 필요하다고 말하였다. 어머니들의 한결같은 바람은 장애 자녀를 데리고 필요한 치료를 받고 자 이곳저곳을 찾아 헤매고 다니기 보다는 한 곳에서 아들에게 필요한 모든 지원이 해결되는 ‘찾아오는 서비스’ 체계가 갖추어지는 것이라 하였다.

아이 데리고 여기 갔다 저기 갔다 시간이랑 체력이 얼마나 소모가 되는지. 한 곳에서 모든 서비스를 받았으면... 치료들이 연결이 되어야죠. 딱 한 군데 가서 다 받을 수 있는 그런 게 생겼으면 좋겠다 싶어요. (라-O, p. 7)

둘째, 어머니들은 장애자녀를 둔 가정의 과중한 경제적 부담을 덜어줄 수 있는 실제적인 경제적 지원의 제공 뿐 아니라 치료비의 의료보험제도 적용 등의 제도상의 지원 확장으로 부모들이 겪는 경제적 부담을 덜어 주는 방안을 강력하게 요구하고 있었다.

성형같은 건 자기가 미용을 목적으로 하기 때문에 의료보험 안되지만 언어치료는 미용을 목적으로 하는 것도 아닌데 의료보험이 안되는 게 이해가 안돼요. 우리 아이들 말 못하는 건, 그건 아니지요. 필요하기 때문에 하는 거잖아요 이게 왜 의료보험이 안되는지 무조건 다 부모가 자식 낳은 죄로 부모가 다 해라. 그건 너무한 거예요. (나-E, p. 11)

셋째, 어머니들은 장애를 가진 자녀가 가족 이외의 사람들과 지원을 주고받고 네트워크로 연결될 수 있는 사회적 지원망 체계의 필요성을 절실하게 요구하고 있었다. 이런 기반을 사회체제 안에 마련하여 장애를 가진 부모들이 자연스럽게 지지를 받을 수 있는 시스템이 갖추어지길 바라는 어머니들이 다수 있었다. 자신들이 스스로 결성하고 연결망을 조성하기에는 어려움이 많다고 토로하면서 이를 위해 사회가 구조적으로 어머니들을 연결해주고 지지해 주기를 원하였다.

넷째, 16명의 어머니들은 사회 속에서 다양한 차별과 냉대의 문제를 개선하기 위해 사회인식 개선의 필요성을 제기하였다. 어머니들을 가장 힘들게 하는 요인은 물질적인 면이나 제도가 아니라 장애를 바라보는 사회의 부정적인 인식과 순간순간 옥죄어 오는 차별이었다. 어머니들의 한결같은 소망이 장애를 가진 자녀들이 다른 사람으로부터 수용되고 자연스럽게 이해되는 날이 오는 것이라고 말하고 있었다.

사람들 마음에 두려움이... 딱 벽이 있어요. ○○이 뿐 아니라 다른 장애아에 대한 것도... 그거 넘으면 다 통할 수 있을 텐데. 뭐랄까... 우리는 코미디프로를 봐도 ○○이가 깔깔 웃으면 재가 알아들으니 까 웃지... 하고 생각하는데, 지가 뭘 안다고 웃나 하는 반응이에요. (가-A, p. 4)

아이를 데리고 서 있었는데, 서 있었는데 초등학교 4학년 된, 초등학교 4학년이면 웬만큼 자기를 알고, 인격도 어느 정도 된다고 생각하는데... 엄마가 손을 잡고 있는데도, 신호등에서 앞에 딱 오더니 “너 바보라며? 너 장애인이라며? 너 말도 못한다며? 말해 봐, 말해 봐” 이러는 거예요 어... 저는 정말, 지금도 막, 얘기하면서도 소름끼치는데...(중략) 너무 기가 막혀서... 정말... (나-F, p. 11)

V. 논의 및 제언

아동의 의사소통 문제는 어머니를 포함한 가족 구성원 모두의 생활과 연관되어 가족 전체의 삶 속에서 어머니 뿐 아니라 가족 전체의 구성원들에게 어려움을 주게 된다. 의사소통 장애아동의 지원은 아동의 개별적인 요구사항을 고려하여 개별화된 가족지원 서비스를 제공함으로써 가정, 학교, 지역사회에서의 문제를 해결하고 완화하도록 제공되어야 한다. 본 연구의 결과가 시사하는 바는 다음과 같다.

첫째, 의사소통 장애아동의 부모들을 위해 실질적인 정보를 제공하고 부모들 간의 공감대를 형성할 수 있도록 자조그룹의 결성을 지원해야 한다. 연구 결과에 의하면 대부분의 어머니들이 장애아동 부모 모임의 필요성을 인식하고 있으며, 같은 처지에 있는 어머니들과 자녀에 대한 어려움을 나누고 여러 가지 정보를 교환하는 것을 통해 대처방안을 마련하는 것으로 나타났다. 그러므로 장애아동의 부모 집단, 형제지원 집단, 아버지 집단과 같은 자조집단의 육성을 장려하여 이들 집단의 구성원들이 스스로 정보를 교환하고, 상호 지원을 하며, 스스로의 권익을 옹호하는 활동 등을 할 수 있도록 사회가 지원하는 일은 대단히 중요하다(이미선·김경진, 2000). 이러한 자조집단 결성은 정부, 지방자치단체, 지역사회 내의 특수교육기관이나 관련기관을 통하여 활성화하는 것이 요구된다.

둘째, 본 연구에 참여한 어머니들은 적극적인 의미의 부모교육 참여를 희망하면서 부모교육 및 지원프로그램의 필요성을 언급하였다. 부모교육은 어머니 뿐만 아니라 전체 가족구성원을 대상으로 실시되기를 원하였고, 개별 가족의 기능을 평가한 후 가족에 초점을 둔 전략과 자원을 제공할 수 있는 내용으로 구성되기를 원하였다. 그러므로 특수교사 및 관련 전문가들은 가족이 스스로의 능력을 강화(family empowerment)하는 데 필요한 지식과 기술을 습득할 수 있도록 개별화된 가족참여와 지원을 제공해야 한다(O'Shea et al., 2001). 특히 지금까지의 부모교육은 주로 어머니를 대상으로 실시되어 왔으나 본 연구 결과에 의하면, 아버지와 형제를 포함한 가족 구성원 전체를 대상으로 하는 가족교육 프로그램이 실시되어야 할 필요성이 명확해 진다. 부모교육의 내용으로는 장애아동의 미래를 위한 계획을 수립할 수 있고 가정에서 교사로서 아동을 가르치고 이들과 직접 상호 작용하는 방법과 구체적인 의사소통 방법과 기술에 대한 것을 담아야 한다. 이는 현재 이루어지고 있는 대다수의 부모교육의 내용이나 방법이 제한적이며, 형식적인 것을 탈피해야 함을 지적하는 것이다.

셋째, 의사소통 장애아동을 위한 서비스 확대와 국가차원의 지원체제가 필요함이 제기되었다. 의사소통의 힘은 다른 사람이 자신의 몸짓, 눈 깜박임 등을 이해하려고 노력하고 알아줄 때의 느낌이며 의사소통의 기쁨은 주변사람들의 이해정도에 따라 영향을 받기 때문에 무엇보다도 아동의 표현능력을 증진시키기 위한 교수 전략이 가장 필요하다(Beukelman & Mirenda, 1998). 그러나 지역별 장애인복지관이나 치료교육기관의 많은 대기자 수, 관련기관간 협력의 부족, 일원화된 관리 체계의 미비 등은 장애아동을 진단·평가하고 교육을 실시하는 데 어려움을 가중시킬 뿐만 아니라 특수교육 정보에 관한 경험이 부족한 어머니들로 하여금 적절한 교육기관을 찾는 어려움을 가중시키고 있다. 현재 특수교육 현장에서 운영되는 치료교육활동은 언어치료 외에 각종 치료영역을 교사 혼자 담당하고 있어 전문성이 떨어진다는 지적이 제기되고 있으며 이를 개선하기 위한 대안으로서 특히 언어치료와 관련하여 언어치료기관의 양적인 확대와 질적인 향상에 대한 요구와 함께 현재 특수학교에서 실시하고 있는 치료교육활동이 확대되고 치료교육활동의 전문성이 보완되어야 함을 시사하고 있다(김영태, 2004). 치료기회를 확대하기 위해서는 특수교육기관 뿐 아니라 국·공립기관 및 민간단체가 의사소통 장애아동의 연령 제한을 벗어나 지역사회에서 쉽게 이용할 수 있는 다양한 과정의 치료교육 프로그램을 실시하도록 해야 한다. 현재 특수학교에서의 치료교육은 특수교육진흥법시행령 제16조 제②항의 “1. 정신지체, 지체부자유, 정서장애(자폐성을 포함한다) 및 중복장애를 지닌 특수교육대상자를 치료 교육하는 특수교육기관의 경우 총 학급수가 6개 학급 이하인 때에는 1인을 배치하고, 6개 학급을 초과하는 때에는 초과하는 6학급마다 1인을 추가하여 배치한다”는 기준에 의해 실시되고 있으나 장애아동에 대한 치료교육의 중요성, 부모의 치료교육에 대한 높은 요구 및 장애아동 부모의 상당한 치료교육비 지출을 고려할 때 이들의 배치기준을 확대할 수 있는 방안이 마련되어야 하며 치료교육 교사의 전문영역별 연수를 강화해야 한다.

이상의 치료교육의 기회와 관련하여 간과할 수 없는 부분이 치료에 대한 경제적 지원이다. 현재 장애인복지법에서는 지체장애인에 대한 물리치료에 대해서는 의료보험을 적용하고 보장구 구입 시에도 이에 대한 경제적 지원을 보장하고 있으나 언어치료의 경우에는 전적으로 가정에서 부담을 하고 있는 형편이며 보완·대체 의사소통도구와 같은 보조공학 도구를 구입했을 경우에도 세금감면이나 보험혜택을 전혀 받지 못하고 있는 실정이다. 그러므로 장애아동의 개별적인 요구에 부합하는 개별화된 서비스 차원에서 의사소통 장애아동에 대한 언어치료와 보조공학 도구에 대한 의료보험법을 개정하고 언어치료 관련 교육기자재에 대한 의료보험 유형을 확대하여 장애아동 가족의 경제적인 문제를 경감시키는 것이 요구된다. 또한 장애아동을 부양하는 가족에게 장애아동 부양 수당, 세금 감면 등의 경제적 지원, 의료비 및 보조 장비 지원, 장애아동 보육지원 및 기타 상담, 가사 보조 등과 같은 다양하고도 실제적인 지원의 확대가 요구된다.

넷째, 서비스의 제공은 아동의 요구에 적절하게 대응할 수 있도록 하나의 체제 안에서 조직적, 협력적인 접근으로 이루어져야 한다. 장애아동 및 그 가족이 필요로 하는 지원이나 서비스가 각 기관별로 제공되고 있는 실정이므로 이러한 지원과 서비스를 조정하여 일괄 관리 체계로 통합하는 노력이 필요하다. 특수교육기관, 특히 다양한 인적·물적 자원을 갖추고 있는 특수학교는 지역사회 내 관련 공

공·민간기관이나 단체들에서 제공하는 장애아동과 가족에 대한 지원을 가족에게 연계하고 조정하여 가능한 한 특수교육기관이라는 단일한 장소에서 통합하여 제공하도록 한다. 그러기 위해서는 그들이 다니는 특수교육기관에서 관련서비스를 받을 수 있도록 서비스 조정자(service coordinator)의 역할을 하는 전문가의 역할정립이 필요하다(O'Shea et al., 2001).

또한 이러한 서비스를 제공함에 있어 전문가 간의 의사소통과 가족과의 파트너십이 강조되어야 하며 장애아동이 통합되는 추세에 따라 일반학교의 담임교사와 특수교사까지도 협력의 대상에 포함되어야 할 것이다. 이러한 협력을 바탕으로 의사소통 장애아동의 가족을 지원할 수 있는 사회적 지원망을 확보한다면 어머니들이 겪는 어려움의 대처방안은 훨씬 다양해질 수 있다. 이를 위해서는 의사소통 장애아동이 지역사회 속에서 부정적인 경험을 하지 않고 관계를 형성할 수 있도록 정부, 지방자치단체 및 특수교육 관련기관에서는 사회의 이해와 관심을 높일 수 있는 다양한 인식개선 활동을 전개하여 지원적인 환경을 조성해야한다. 또한 장애아동과 가족에 대한 종합적인 지원과 서비스의 필요성을 인식시키고 그 가치를 널리 알리는 노력이 요구된다.

참 고 문 헌

- 김동연(1996). 정신지체아 어머니의 자아 긍정감과 가족 스트레스에 관한 연구. 『언어치료연구』, 5(1), 15-40.
- 김영미(1997). 취학전 자폐유아 부모교육 요구도 조사연구. 대구대학교 대학원 석사학위논문.
- 김영태(2004). 특수교육 현장에서 치료교육 제공의 문제점 및 전문가 양성 방안. 특수교육현장에서 바람직한 치료교육교사 양성방안. 『장애아이 we can: 공청회 자료집』, 8-35.
- 김윤옥(2001). 『교육연구를 위한 질적 연구방법과 설계』. 서울: 문음사.
- 김정연·박은혜(2003). 중도 뇌성마비 아동의 의사소통 기술 증진을 위한 AAC 대화상대자 훈련. 『특수교육연구』, 2(1), 37-58.
- 김혜란(1997). 장애아동 가족체계 지원에 관한 소고. 『재활복지연구』, 1, 60-78.
- 도봉서원종합복지관(2003). 『부모지원조사연구』. 서울: 도봉서원종합복지관.
- 오혜경·전혜연(2004). 장애아동 부양가족의 양육부담 및 가족지원욕구. 『한국가족복지학』, 9(1), 79-101.
- 이미선·김경진(2000). 『장애 영유아 가족지원 방안 연구』. 안산: 국립특수교육원.
- 이소현(2000). 특수교육에 있어서의 바람직한 가족 참여를 위한 지원 및 중재 방안 고찰. 『언어청각장애연구』, 5(1), 174-191.
- Beukelman, D. & Mirenda, P.(1998). *Augmentative and alternative communication. management of severe communication disorders in children and adults*. Baltimore, MA: Paul H. Brooks Publishing Co.
- Bowe, F.(2000). *Physical, sensory, and health disabilities*. Columbus, OH: Merrill Publishing Co.

- Broderick, A. A.(2001). "Say just one word at first": The emergence of reliable speech in a student labeled with autism. *Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps*, 26(1), 13-24.
- Bruno, J. & Dribbon, M.(1998). Outcomes in AAC: Evaluating the effectiveness of a parent training program. *Augmentative and Alternative Communication*, 14(2), 59-67.
- Carr, E. G. & Durand, V. M.(1985). Reducing behavior problems through functional communication training. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 18, 111-126.
- Gammon, E. A. & Rose, S. D.(1991). The coping skills training program for parents of children with developmental disabilities: An experimental evaluation. *Research on Social Work Practice*, 1, 54-63.
- Gargiulo, R. M. & Graves, J. B.(1991). Parental feelings. *Childhood Education*, 67(3), 176-178.
- Glesne, C. & Peshkin, A.(1992). *Becoming qualitative researchers*. New York, NY: Longman.
- Goetz, J. P. & LeCompte, M. D.(1984). *Ethnography and qualitative design in educational research*. London: Academic Press, Inc.
- Hunt, P., Alwell, M. & Goetz, L.(1988). Acquisition of conversation skills and the reduction of inappropriate social interaction behaviors. *Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps*, 13(1), 20-27.
- Light, J.(1997). "Communication is the essence of human life": Reflections on communicative competence. *Augmentative and Alternative Communication*, 13, 61-70.
- Light, J., Collier, B. & Parnes, P.(1985). Communicative interaction between young nonspeaking physically disabled children and their primary caregivers: Part I - discourse patterns. *Augmentative and Alternative Communication*, 1(3), 74-83.
- Mahoney, G. & Powell, A.(1988). Modifying parent-child interaction: Enhancing the development of handicapped children. *Journal of Special Education*, 22, 82-96.
- Matas, J., Mathy-Laikko, P., Beukelman, D. & Legresley, K.(1985). Identifying the nonspeaking population: A Demographic study. *Augmentative and Alternative Communication*, 1, 17-31.
- O'Shea, D., O'Shea, L., Algozzine, R. & Hammitte, D.(2001). *Families and teachers of individuals with disabilities: Collaborative orientations and responsive practices*. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Patton, M. Q.(1990). *Qualitative evaluation and research methods*. Newbury Park, CA: Sage Publications Inc.
- Soodak, L. C. & Erwin, E. J.(2000). Valued member or tolerated participant: Parents' experiences in inclusive early childhood settings. *Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps*, 25(1), 29-41.

- Turnbull, A. P. & Ruef, M.(1997). Family perspectives on inclusive lifestyle issues for people with problem behavior. *Exceptional Children*, 63(2), 211-227.
- Warren, S. & Kaiser, A.(1986). Incidental language teaching: A critical review. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 51, 291-299.
- Yoder, P. J. & Davies, B.(1990). Do parental question and topic continuations elicit replies from developmentally delayed children?: A sequential analysis. *Journal of Speech and Hearing Research*, 33, 563-573.

ABSTRACT

**Difficulties and Support Needs Perceived by the
Families of Children with Communication Disorders
: A Qualitative Inquiry**

**Jeong Youn Kim, Keum Jin Lee,
Eun Suk Kim, Joo Hye Kim,**

(Dept. of Special Education, The Graduate School,
Ewha Womans University)

Ji Yeon Park

(Dept. of Special Education, Ewha Womans University)

Interviews with 16 mothers of children with communication disorders were conducted in order to investigate the families' experiences through their children with communication disorders. Three themes emerged from the qualitative analysis: (1) the impact of the child's communication difficulties on family life, (2) the coping strategies that the families use in order to overcome the difficulties, and (3) the support needed for raising children with communication disorders. Implications for policy and practices for children with communication disorders and their families are provided.

Key Words: late-talker, assessment variables for predicting expressive vocabulary development, communicative intention inventories

-
- ▶ 게재 신청일: 2005년 1월 31일
 - ▶ 게재 확정일: 2005년 3월 19일

- ▶ 김정연(제 1 저자): 이화여자대학교 특수교육학과 박사과정, e-mail: hanle3532@hanmail.net
- ▶ 이금진(공동저자): 이화여자대학교 특수교육학과 박사과정, e-mail: keumjin@ewha.ac.kr
- ▶ 김은숙(공동저자): 이화여자대학교 특수교육학과 박사과정, e-mail: eskim@kise.go.kr
- ▶ 김주혜(공동저자): 이화여자대학교 특수교육학과 박사과정, e-mail: joohye222@hanmail.net
- ▶ 박지연(공동저자): 이화여자대학교 특수교육학과 교수, e-mail: jpark@ewha.ac.kr